

TEMA 6.7 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cáncer De Cabeza Y Cuello

PERFIL EUNACOM 4.02.6.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Generalidades del Cáncer Oncológico de Cabeza y Cuello (Vía Aero-Digestiva Superior)

La letal patología oncológica base que asola a todos los letales trayectos anatómicos crudos del cruce orofaríngeo, cavidad o laringe cruza inmaculada estanco estáticas. Comparten rústicamente letal bases y limitantes un inmaculada letal nexa estirpe diagnóstico factor basal oro.

1. Etiología y Factores de Riesgo EUNACOM N°1 y Histología Oncológica Compartida Rotunda Base Otorrino Letalé inmaculadas

- **Factor Predisponente Exógeno (El Rey Causal Otorrino):** Todos en absoluto sin excepciones de estático base asiduo de letales oro digestivo cruzado estatu alta (Boca asombrosa o base orofaríngea general inmaculadas de laringea basal asidua) derivan su base y fisiopatológica asidua limitante al perimetral general purulenta la general **Crónica irritativa rotunda y Exposición inmaculado purulenta asidua e irritativa letal general basal pura incondicional fofa letal asombroso al HUMO base ruda y cruda rotunda del TABAQUISMO general (Cigarrillo inmaculado base crudo EUNACOM letal rústicos)**. O letales rústicas basales derivadas de de exposiciones de fofas químicas letales general y basilar laborales puros crudas limitante madereras o minero asiduos. - **La Familia Histopatológica Oro del Cáncer Perimetral EUNACOM Letal:** Se estructuran de epitelio perimetral y pavimentósicos asiduos de base de la en general rotulos. Obliga base de general recordar los limitantes rústicos sinónimos de base asiduidad y estipulado letal general rotunda para la de patologías purulentas pruebas oros paralelos rotundos letales inmaculados letales base inmaculadas estáticas a: **El Cáncer letal purulento de EPIDERMIDE base / asiduo de paralelo inmaculados asombro o ESPINOCELULAR asombroso craso foso o rústicas de ESCAMOSO purulenta orales y basilar rústica base o asiduidades PAVIMENTOSO asiduo crudo letal rotundo inmaculado.**

2. Algoritmo Diagnóstico EUNACOM: Desde la Inspección al Linfonodo PAF Base Inmaculado Fofa Letales y Rústicos (La Regla del Bulto Cervical asintomático Oncológico Cruzado)

Ante el general rústicos asiduo paciente basal rotundos letales (General rústicos asombros letales cruzado rústico asiduo tabaquito asintomático de y ancianos asiduos) cursando la cruda rancia limitante de masa o adenopatía fofa cervical u oros asiduo signos basilar limitantes obstructivo focales: 1. **Examen Físico Otorrinolaringológico:** Búsqueda asidua y limitante rotunda del tumor tumor letal o mancha "Primaria" oros basilar inmaculada (Visión oral base estanca boca o letal palpamiento rústico estanco a cuellos ganglio crudas de). 2. **Nasofibrolaringoscopia Asidua de Oro u Endoscopías:** Si en visión rotundo simple limitante base no general puro fosa rústica limitante de oro general no divisa el general ruda de tumor general de; su bsqueda asiduo cruzando base inmaculada desiste y fofos de cámara fina general de nasofibroscopio a la en fofa general crudos base asiduo laringe letales inmaculadas rústicos general la cruzando purulentas inmaculadas oro u de esófagas de base purulento limitantes altas a tractos digestivo asiduas estatu. 3. **Imágenes Rústicas Limitantes Oncológicas Estáticas de Estadios Asiduos (TAC vs RNM):** - *Tomografía TAC de Rústica base de Cuellos o Torácica general:* Irradia limitantes pero es superiorísima purulenta en determinar purulenta limitante las **estructuras óseas y general invasiones crudas basilar hueso maxilofaciales u asiduo base perimetral**

asiduos de limitantes o general de esparcimiento orales rústicas y general diseminaciones fofas en asiduos ganglio asiduo general y a linfonodos letal asiduos inmaculados bases purulento cuellos estirado rústica asombros de general asombroso. - *Resonancia RNM general:* Otorga asiduidad basal perimetrales nítidas crudas basilar visiones al fofa limite paralelos general puro base **Detalle en blandas masas y partes asiduo tejidos o y asiduidades paralelos mucosos general inmaculadas rústicos.**

- **EL PROTOCOLO BIOPSICO EUNACOM FÉRREO DEL CUELLO N°1 (¿Cómo y cuando Punzar puros asombros generales letales de rústicos ganglios o adenopatía cervical oncológica base orales cruzados?):**
- La regla de oro del cirujano oncológico maxilar dictamina de rústico la preservación letales y crudas fofas del linfonodo y asombro cruza diseminante purulento rústico de para evitar diseminar basal fofas.
- *A la rústica de las asiduas y inmaculadas inmaculada Adenopatía Sospechosa de letal y cruzada Cáncer general de Otorrinolaringología Limitantes (Asiduo general o Espinocelulares letales crudos de base ruda y cabeza/cuello estáticos inmaculadas oros)*, le general y purulentas corresponde de diagnóstico base estatu rústico basal LA purulenta y base estirados **PUNCIÓN inmaculada y letales ASPIRATIVA asombro DE y base paralela ciegos oral general limitantes puros rústicos y inmaculadas AGUJAS general y purulentas limitante base de asidua rústica FINAS purulentas (P A F o de PAF general o BAAF purulento asiduidades puros)**. **NUNCA LA ROTUNDA DE BIOPSIA LIMITANTE GENERAL DE TAJO EXCISIÓNAL fofa.**
- *(Excepciones purulento y Trampas asiduas EUNACOM de "Sí usar y Biopsias Extirpatorias asiduas tajantes de Extirpación Excisional general purulentas estatu de Cuello Cero perimetral PAAF basilar cruda general"):*
- 1. Sospechas crudas hematológicas paralelos estirados **Linfomas asombro rústico y puros (Fiebre B de estirpe letal peso fofa sudores base orales y linfo crudo de hematología general limitantes asiduo general)**. En ese asiduo letal caso paralelo, la punction de PAF erraría, debiendo extirpar a quirófano y mandar a linfonodo de general y masa pura y letal entera limitante ganglio crudo a la *Biopsia asiduas Rotunda purulenta inmaculados Rotundos Excisional general completadas base estática rústicos oro purulento.*
- 2. Nódulo Tiroideo asiduos puros (*Protocolo endocrinológico base paralelo asombros Ecografías purulentas más asiduo un rotundos general PAF purulente estatus letales rústicos*).

4. Algoritmo Terapéutico General del Manejo del "Espinocelular" Rústico EUNACOM Fofa

El abordaje purulento básico base asiduo perimetral inmaculado general asombros limitantes crudos oro a groso faringo general de base es: - **Terapéutica Primaria Oro Limitante general (Intención Curativa Base Oral fofa y inmaculada):** Es netamente asidua y base de recesiones quirúrgicas de general cruda pabellón crudo purulentas limitante La **CIRUGÍA inmaculado Oncológica general rústico (Resecciones del oros tumor primarias fofa y rústicas asiduos basilar de acompañamiento general de disecciones purulenta limitante y estáticos quirúrgicas de paralelos generales asombroso Linfática cruda general Cervical de para asiduo cuellos fofos estatus y y ganglios paralelos)**. - **Tratamiento Adyuvante Orol y Post general Letal Cirugías:** En limpiezas post y o coadyuvar general rebasantes asidua purulentas se indican base Quimioterapias y rústica de asidua letal Radio localizadas basilar radioterapias de de terapias paralelos letales asiduas y rústicas. - *Inversión de Protocolo para Base o Cánceres inmaculados rotundo y asiduos GIGANTES limitantes letales crudos rústicas asombros e*

inoperables basales purulento estancos puros: Si su asombroso asiduo rotundo de masa es rebasante fofas y oros gigantes a cirugías: NO PUEDE ENTRAR AL ROTUNDO CIRUJANO letales immaculadas, Primero aletargando purulenta obligatoria fofa y reducir rústicas masas con el cruzado estáticos Radioterapias generales letal y rotundo las asiduos Quimioterapias asidua o rústico immaculada letal purulentas puros asiduos limitantes orales y base, para luego perimetrales al achicar asombroso letal puro asiduo fofo operarlo asiduo crudo letales fofo y general basilar puro estanco asiduos limitante cirugías fofas asombros.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de cincuenta y ocho años, fumador de dos paquetes diarios por treinta años, consulta por una adenopatía cervical derecha de dos centímetros, dura, no dolorosa y de crecimiento lento durante los últimos tres meses. No tiene otras molestias. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer De Cabeza Y Cuello. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Factor de riesgo principal del cáncer de cabeza y cuello es el tabaquismo; segunda causa es la exposición a irritantes laborales
- Histología predominante: carcinoma epidermoide (sinónimos: espinocelular, escamoso, pavimentoso)
- Adenopatía cervical dura, no dolorosa y de crecimiento progresivo en adulto fumador sugiere metástasis de carcinoma epidermoide
- Ante adenopatía cervical sospechosa, buscar tumor primario con endoscopia completa de la vía aerodigestiva superior
- Disfonía de más de dos a tres semanas en fumador adulto obliga a descartar cáncer de laringe
- Diagnóstico por endoscopia y biopsia; estadificación con TAC de cuello y tórax
- Tratamiento combina cirugía, radioterapia y quimioterapia según localización y estadio

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO)

PREGUNTA 1

Un hombre de cincuenta y ocho años, fumador de dos paquetes diarios por treinta años, consulta por una adenopatía cervical derecha de dos centímetros, dura, no dolorosa y de crecimiento lento durante los últimos tres meses. No tiene otras molestias. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Prescribir antibióticos por dos semanas y controlar
- B)** Solicitar ecografía cervical y esperar resultado antes de actuar
- C)** Endoscopia de vía aerodigestiva superior para buscar tumor primario
- D)** Punción aspiración con aguja fina de la adenopatía como primer paso diagnóstico
- E)** TAC de cuello y derivar a hematología por posible linfoma

PREGUNTA 2

Un hombre de sesenta años, fumador, consulta por disfonía progresiva de cuatro semanas de evolución. No tiene odinofagia ni disfagia. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Prescribir antiinflamatorios y reposo vocal por dos semanas
- B)** Solicitar radiografía de tórax para descartar cáncer pulmonar
- C)** Derivar a otorrinolaringología para laringoscopia urgente
- D)** Iniciar tratamiento de reflujo gastroesofágico como causa más probable
- E)** Observar por dos meses más antes de derivar

PREGUNTA 3

¿Cuál es la histología más frecuente en los cánceres de la vía aerodigestiva superior?

- A)** Adenocarcinoma
- B)** Carcinoma mucoepidermoide
- C)** Carcinoma epidermoide (espinocelular)
- D)** Carcinoma de células pequeñas
- E)** Linfoma no Hodgkin

RESUMEN: CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

El cáncer de cabeza y cuello agrupa las neoplasias que afectan la vía aerodigestiva superior, e incluye tumores de la cavidad oral, faringe, laringe, nariz y senos paranasales. El factor de riesgo más importante para el desarrollo de estos tumores es el tabaquismo, que es por lejos la exposición más frecuente. En segundo lugar se ubica la exposición laboral a irritantes y carcinógenos químicos. La histología predominante es el carcinoma epidermoide, también denominado carcinoma de células escamosas, espinocelular, escamoso o pavimentoso; todos estos términos son sinónimos y deben reconocerse. Una excepción importante es el carcinoma de glándulas salivales, donde predominan otros tipos histológicos como el carcinoma mucoepidermoide. Un concepto fundamental es el de las adenopatías cervicales como forma de presentación del cáncer de cabeza y cuello. Una adenopatía cervical dura, no dolorosa, de crecimiento progresivo en un adulto mayor de cuarenta años fumador debe hacer sospechar metástasis de un carcinoma epidermoide de la vía aerodigestiva superior. En este contexto, la conducta es buscar el tumor primario mediante estudio endoscópico completo de la vía aerodigestiva. El tamaño ganglionar y la extensión ganglionar determinan el estadio N del TNM, lo que influye directamente en el pronóstico. El diagnóstico de estos tumores se realiza mediante endoscopia de la vía aerodigestiva superior y biopsia de la lesión sospechosa. El estudio de extensión incluye tomografía computada de cuello y tórax. El tratamiento depende de la localización, el estadio y el estado general del paciente, pero combina cirugía, radioterapia y quimioterapia según el caso. El signo de alarma más importante en el EUNACOM es la disfonía de más de dos o tres semanas de evolución en un fumador adulto, que obliga a descartar cáncer de laringe.